

Document 2 : Dépistage des cancers – Pour qui et quand ? (Synthèse)

Le document rappelle le calendrier des dépistages nationaux organisés :

- **Cancer du sein** : Pour les femmes, tous les 2 ans de 50 à 74 ans.
- **Cancer du col de l'utérus** : Pour les femmes, tous les 3 ans de 25 à 30 ans, puis tous les 5 ans de 30 à 65 ans.
- **Cancer colorectal** : Pour les hommes et les femmes, tous les 2 ans de 50 à 74 ans.

Note importante : En cas d'antécédents personnels ou familiaux, les modalités de suivi doivent être adaptées avec son médecin.

Document 3 : Traitements systémiques des cancers du sein localisés (RE+/HER2-)

Cette section détaille les recommandations cliniques pour le sous-type histologique spécifique RE+ et HER2 négatif ou faible.

Échanges médecin-patiente & Choix éclairé

- **Chimiothérapie néoadjuvante (avant chirurgie)** : Les objectifs à expliquer à la patiente incluent la diminution de la taille de la tumeur pour la rendre opérable ou pour permettre une chirurgie conservatrice (garder le sein), l'évaluation de la chimio-sensibilité de la tumeur, et une meilleure planification (tests génétiques type BRCA).
- **Hormonothérapie adjuvante (après chirurgie)** : L'accent doit être mis sur l'observance à long terme. Le clinicien doit expliquer clairement le mécanisme d'action, gérer les effets indésirables potentiels et évaluer régulièrement la tolérance lors des transitions hôpital-ville.

Recommandations – Chimiothérapie Néoadjuvante (CTNA)

- **Indications** : Mêmes indications qu'en adjuvant, ainsi que pour les cancers inopérables d'emblée ou inflammatoires. Il n'y a pas de différence de survie globale entre la chimiothérapie faite avant ou après la chirurgie.
- **Schéma standard** : 6 à 8 cycles séquentiels à base d'anthracycline, cyclophosphamide et taxane. Un schéma dense en dose ou sans anthracyclines est possible selon les contre-indications ou les comorbidités.
- **Exclusions** : Les thérapies ciblées, les immunothérapies, le carboplatine, la gemcitabine et le fluorouracile n'ont pas d'indication en néoadjuvant pour ce sous-type. La CTNA n'est pas recommandée au-delà de 70 ans pour les formes opérables (sauf cas particuliers validés en RCP).

- **Délai chirurgical** : La chirurgie doit intervenir idéalement 21 à 30 jours après une CTNA à base d'anthracycline/docetaxel, et 10 à 20 jours après un traitement par paclitaxel hebdomadaire.

Recommandations – Hormonothérapie Adjuvante

- **Principes généraux** : Indiquée pour les cancers invasifs $\geq 10\%$. Pour les tumeurs de très petite taille (pT1aN0 et pT1bN0), la balance bénéfice-risque peut être discutée (abstention possible, surtout chez les patientes âgées). Chimiothérapie et hormonothérapie ne doivent jamais être administrées simultanément.
- **Femmes non ménopausées au diagnostic** :
 - *Haut risque* : Association d'un agoniste de la LH-RH (injection mensuelle conseillée) avec un Inhibiteur de l'Aromatase (IA) pendant 5 ans. Extension possible à 7-10 ans pour les stades II-III.
 - *Faible risque* : Tamoxifène seul ou association agoniste LH-RH + IA pendant 5 ans.
 - En cas de prolongation après le tamoxifène initial : poursuite par tamoxifène ou (si la patiente est devenue ménopausée) bascule vers un IA.
- **Femmes ménopausées au diagnostic** :
 - Traitement par Inhibiteur de l'Aromatase (IA) pendant une durée minimale de 5 ans.
 - Pour les risques faibles, le tamoxifène seul ou en traitement séquentiel avec un IA est envisageable.
 - Pour les stades II-III, une prolongation de 7 à 10 ans est recommandée après réévaluation à 5 ans (le score CTS5 peut guider cette décision).
- **Chez l'homme** : Le traitement hormonal de référence reste le tamoxifène pour une durée minimale de 5 ans.

Thérapies ciblées adjuvantes

- **Inhibiteurs de CDK4/6** : L'**abémaciclib** est recommandé pendant 2 ans en association avec l'hormonothérapie pour les atteintes ganglionnaires importantes ou les tumeurs de grande taille (N2 ou N3, ou N1 associé à un grade 3 ou une taille ≥ 5 cm). Il doit être débuté dans les 12 semaines suivant l'hormonothérapie. Le palbociclib et le ribociclib ne sont pas indiqués dans cette situation.
- **Inhibiteurs de PARP** : L'**olaparib** est recommandé pendant 12 mois pour les patientes porteuses d'une mutation germinale *BRCA1/2* à haut risque (atteinte ganglionnaire pN2 ou score CPS-EG ≥ 3 après chimiothérapie néoadjuvante). Il commence dans les 12 semaines après la fin de la radiothérapie.

Bilans et suivi d'imagerie (Cas de la CTNA)

- **Bilan initial** : Mammographie et échographie bilatérales (axillaire incluse). L'IRM ou l'angiomammographie ne sont pas systématiques mais recommandées en cas de discordance ou de tumeur difficile à mesurer. Bilan d'extension à distance (TEP-TDM au FDG de préférence) recommandé à partir du stade cT2 N1 Mx ou $\geq$ cT3.
- **Suivi pendant le traitement** : Surveillance clinique obligatoire. Pose d'un clip sur la lésion principale recommandée avant la CTNA pour guider la chirurgie conservatrice. L'IRM en milieu de traitement n'est pas recommandée.
- **Bilan de fin de traitement** : Évaluation clinique et radiologique (mammographie + échographie, complétée par IRM si faite initialement) au plus près de la fin de la chimiothérapie. La chirurgie reste indispensable pour confirmer une réponse histologique complète (évaluée par le score de charge tumorale résiduelle RCB).